



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

LAPORAN BULANAN INSTALASI LABORATORIUM MEI TAHUN 2026

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang
Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874
Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com
www.rs-primahusada.com

DAFTAR ISI

BAB I	3
PENDAHULUAN	3
BAB II	4
GAMBARAN UMUM RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG	4
A. VISI	4
B. MISI	4
C. MOTTO	4
D. 7 NILAI BUDI UTAMA	4
E. STRUKTUR ORGANISASI.....	1
BAB III LAPORAN KINERJA LABORATORIUM	1
A. SDM.....	1
B. PENGEMBANGAN PELAYANAN	3
C. KINERJA PRODUKTIVITAS	3
BAB III	27
BAB IV MUTU LABORATORIUM	29
BAB V	31
BAB VI	34
BAB VII	36
JADWAL KEGIATAN.....	36
A. LAMPIRAN KUANTITAS SDM	1
B. LAMPIRAN KUALITAS SDM.....	2
C. LAMPIRAN KLASIFIKASI INVENTARIS	1
D. LAMPIRAN DATA ALAT YANG AKAN DIKALIBRASI	3
E. LAMPIRAN PENAMBAHAN ALAT	4
F. LAMPIRAN PENGgantian ALAT.....	5
G. LAMPIRAN PERBAIKAN ALAT RUSAK.....	6

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka terselenggaranya *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan rumah sakit dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan Kinerja rumah sakit dalam hal ini Rumah Sakit Prima Husada Malang adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban Rumah Sakit Prima Husada Malang untuk mempertanggungjawabkan kinerja, keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi misi Rumah Sakit Prima Husada Malang dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Selain dari tuntutan akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja juga sebagai alat ukur keberhasilan Rumah Sakit dalam mencapai tujuan dan/atau sasaran atau kegiatan utama yang dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja di masa datang, kuncinya adalah penekanan pada tujuan dan sasaran atau program kegiatan yang perlu mendapat perhatian sebagai ukuran keberhasilan.

Rumah Sakit Prima Husada Malang adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan dibidang kesehatan berkelanjutan secara paripurna dengan mengutamakan pengobatan dan pemulihan tanpa mengabaikan peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui penyediaan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, penunjang dan tindakan medik.

B. TUJUAN

Tujuan penyusunan Laporan Bulan Juni Tahun 2025 adalah untuk :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan pelayanan antar unit untuk meningkatkan kinerja rumah sakit.

BAB II

GAMBARAN UMUM RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG

A. VISI

Menjadi Rumah Sakit berkualitas prima pilhan seluruh lapisan masyarakat

B. MISI

1. Memberikan Pelayanan Kesehatan dengan Aman, Tepat, Cepat dan Akurat
2. Mengutamakan Kepuasan dan Keselamatan Pasien
3. Meningkatkan Mutu Pelayanan yang Berkelanjutan

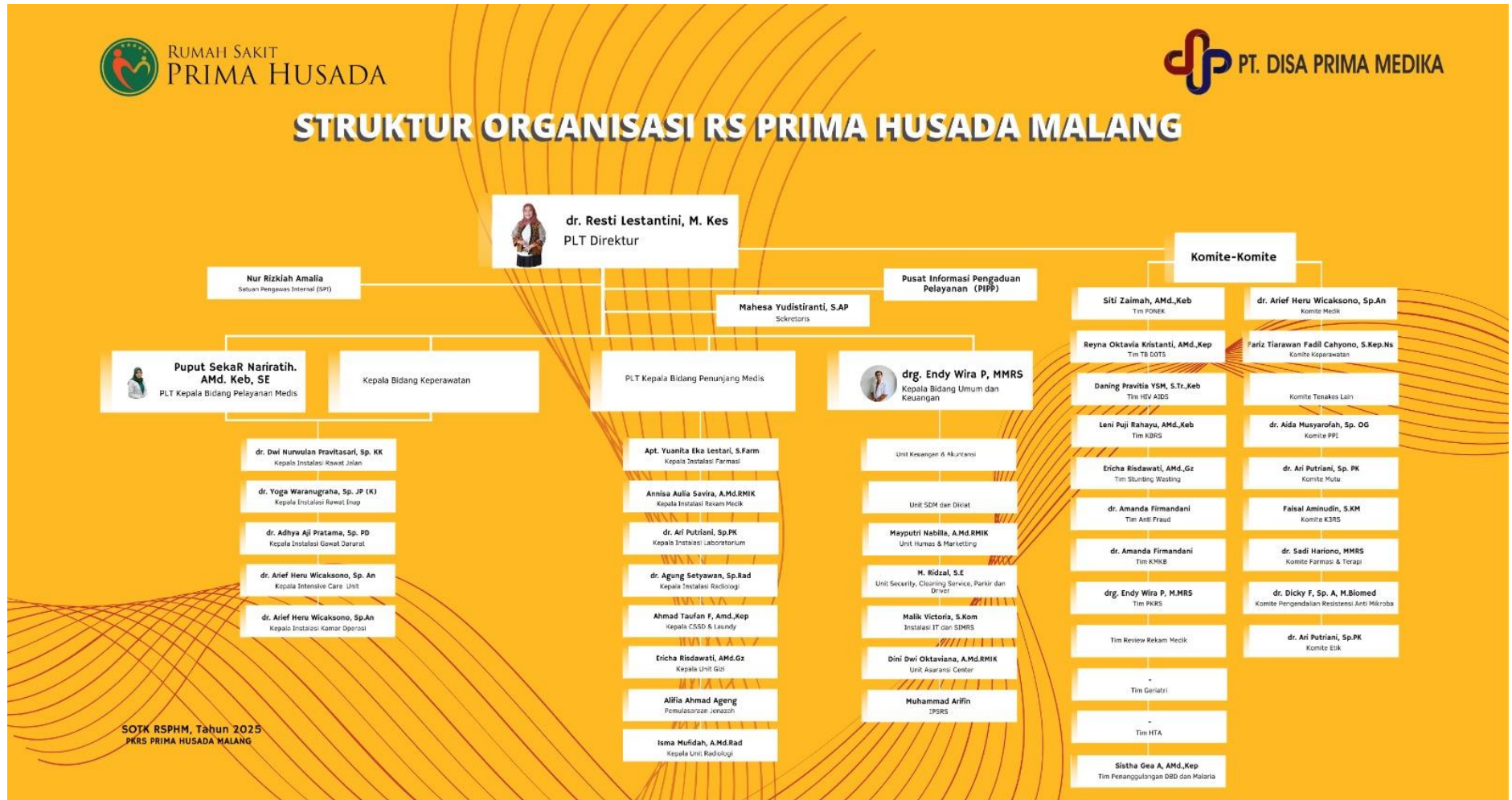
C. MOTTO

Sahabat Menuju Sehat

D. 7 NILAI BUDI UTAMA

1. Jujur
2. Tanggungjawab
3. Visioner
4. Disiplin
5. Kerjasama
6. Adil
7. Peduli

E. STRUKTUR ORGANISASI



BAB III
LAPORAN KINERJA LABORATORIUM

A. SDM

Tabel 1.1.1 Jumlah SDM yang bekerja di Laboratorium

Jabatan	Jumlah SDM			Ket.
	Standar	Mei 2026	Kebutuhan	
Ka Instalasi	1	1	0	
Ka Ruang	1	1	0	
Pelaksana	10	8	0	
Admin	0	0	0	
Jumlah	12	10	-2	-2

Analisa: Berdasarkan hasil analisa kebutuhan SDM pada bulan Mei 2026, diketahui bahwa jumlah kebutuhan tenaga secara keseluruhan adalah sebanyak 12 orang, sedangkan jumlah SDM yang tersedia saat ini adalah 10 orang. Dengan demikian, terdapat kekurangan tenaga sebanyak 2 orang atau defisit sebesar 16,7% dari total kebutuhan.

Secara rinci berdasarkan jabatan:

- Kepala Instalasi: kebutuhan 1 orang, tersedia 1 orang (100% terpenuhi)
- Kepala Ruang: kebutuhan 1 orang, tersedia 1 orang (100% terpenuhi)
- Tenaga Pelaksana: kebutuhan 10 orang, tersedia 8 orang (terpenuhi 80%, kekurangan 2 orang)
- Tenaga Administrasi: tidak terdapat kebutuhan maupun tenaga (sesuai perencanaan)

Kekurangan SDM terjadi pada posisi tenaga pelaksana, yang merupakan tenaga operasional utama dalam menunjang pelayanan laboratorium. Kondisi ini berpotensi meningkatkan beban kerja individu, memperbesar risiko kelelahan kerja (burnout), serta dapat berdampak pada mutu pelayanan dan waktu penyelesaian pemeriksaan.

Sementara itu, pada jabatan struktural (Kepala Instalasi dan Kepala Ruang), jumlah SDM telah sesuai dengan standar yang ditetapkan sehingga fungsi manajerial dan pengawasan tetap berjalan optimal.

RTL: Sebagai tindak lanjut atas kekurangan 2 tenaga pelaksana pada bulan Mei 2026, direncanakan pengajuan penambahan SDM kepada pihak manajemen sebagai solusi jangka panjang. Sementara itu, dilakukan langkah jangka pendek berupa optimalisasi pengaturan jadwal kerja, rotasi tugas, serta pemantauan beban kerja untuk menjaga kesinambungan pelayanan.

Selain itu, dilakukan monitoring terhadap indikator mutu dan waktu penyelesaian pemeriksaan (TAT) guna memastikan kualitas layanan tetap terjaga.

Tabel 1.2.1 Pelaksanaan Orientasi Khusus di Unit bagi Karyawan baru unit Laboratorium RSPH Malang Tahun 2025

No	Nama Peserta	Masuk mg ke	Pembelajaran Yang diterima	Hasil Evaluasi orientasi		
				Pengetahuan ttg regulasi	Praktek keterampilan	7 nilai budiutam/ attitude
1.	-	-	-	-	-	-

Analisis : Selama bulan Mei tidak ada karyawan baru, Karyawan terakhir masuk pada Februari tahun 2025

RTL: -

Tabel .1.3.1 Hasil Pelaksanaan Peningkatan SDM (Diklat) Karyawan di RSPH malang Tahun 2025

NO	Tema DIKLAT /WS/SEM/WB	Jenis Diklat	JUMLAH PESERTA		TGL Pelaksaan	Sertifikat		Hasil evaluasi dalam kinerja sehari-hari
			Hadir	Tidak H		Ada	Tdk	
1.	Akreditasi	Internal						
2.	Mutu	Internal						
3.	PPI	Internal						
4.	MFK-K3	Internal						
5.	Apar	Internal						
6.	BHD	Internal						
7.	KE	Internal						
8.	SKP	Internal						

Analisis : Selama Bulan Mei tidak ada diklat

B. PENGEMBANGAN PELAYANAN

Tabel 2.1 Pengembangan Pelayanan

No	Kegiatan Pokok	Hasil	RTL
1	Pengembangan Pelayanan LIS	- Pemasangan server dan proses dari vendor sudah slesai, menunggu proses blicing dari SIMRS Rumah sakit.	- Proses Blicing SIMRS

Analisis : Masih akan di briching Oleh Pihak SIMRS, Kendala yang di temui pihak simrs masih belum sempat melakukan blicing karena masih ada pekerjaan di SIMRS yang harus di selsaikan terlebih dahulu E Rm.

C. KINERJA PRODUKTIVITAS

	Target	Mar 26%	%	Apr 26%	%	Mei 26%	(Persentase terhadap bulan sebelumnya)
HEMATOLOGI	1950	1427	<5,2%	1727	>17,3%	1677	<2,9%
FAAL HEMOSTASIS	716	710	<3,1%	823	>13,7%	748	<9,3%
HEMATOLOGI LAIN	1	0		1	>100%	0	<100%
URINALISIS	418	232	<11,1%	278	>16,5%	252	<9,3%
ANALISA FEACES	30	22	>36,3%	17	< 22,7	15	<11,7%
FUNGSI HATI	611	281	>1,0%	397	>29,2%	311	<21,6%
LEMAK DARAH	806	744	>0,5%	828	>10,14%	956	>1,1%
GINJAL HIPERTENSI	1394	1257	>9,8%	1570	>19,9%	1515	<3,5%
GULA DARAH	1187	2080	<1,18%	2662	>21,8%	2458	<7,6%
JANTUNG	583	515	>2,9%	669	>23,0%	716	>6,5%
ELEKTROLIT DAN BGA	334	176	<10,2%	242	>27,27%	242	0%
IMUNO SEROLOGI	481	137	<19,8%	165	>16,9%	212	>22,1%

REMATIK	6	4	<50%	3	<25%	6	>50%
ENDOKRINOLOGI	60	44	<38,0	81	>46,6%	94	>13,8
REPRODUKSI	44	47	<21,6	32	>31,9%	52	>38,4%
MIKROBIOLOGI	32	43	>20,9	56	>23,2%	55	<1,7%
Jumlah	8654	7719	<4,5%	9551	>23,7%	9303	<2,5%

Analisa: Secara umum, jumlah pemeriksaan laboratorium bulan Mei 2026 mencapai 9.303, mengalami penurunan sebesar 2,5% dibandingkan bulan April, namun masih berada di atas target yang ditetapkan. Pemeriksaan dengan volume tertinggi didominasi oleh gula darah, hematologi, dan ginjal hipertensi. Beberapa parameter mengalami peningkatan seperti pemeriksaan jantung dan reproduksi, sementara fungsi hati menunjukkan penurunan yang cukup signifikan. Secara keseluruhan, kinerja pelayanan laboratorium tetap baik dengan capaian di atas target, namun perlu evaluasi pada parameter yang mengalami penurunan.

RTL: Berdasarkan hasil evaluasi capaian pelayanan laboratorium bulan Mei 2026, diperlukan beberapa langkah tindak lanjut guna mempertahankan kinerja yang telah baik serta meningkatkan mutu pelayanan pada parameter yang mengalami penurunan. Adapun rencana tindak lanjut yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. **Evaluasi Parameter yang Mengalami Penurunan**
Dilakukan analisis lebih lanjut terhadap pemeriksaan yang mengalami penurunan jumlah, khususnya pada pemeriksaan fungsi hati dan hemostasis, dengan meninjau faktor penyebab seperti jumlah kunjungan pasien, pola rujukan klinis, serta ketersediaan alat dan bahan.
2. **Peningkatan Koordinasi dengan Unit Klinis**
Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan dokter penanggung jawab pasien serta unit pelayanan terkait guna mendorong optimalisasi permintaan pemeriksaan laboratorium sesuai indikasi medis.
3. **Optimalisasi Ketersediaan Sarana dan Prasarana**
Memastikan ketersediaan reagen, bahan kontrol, serta optimalisasi fungsi alat laboratorium agar tidak terjadi hambatan pelayanan yang dapat mempengaruhi jumlah pemeriksaan.
4. **Pengembangan Layanan dan Promosi Pemeriksaan**
Melakukan upaya promosi layanan laboratorium, khususnya untuk pemeriksaan dengan volume rendah, melalui edukasi kepada pasien maupun tenaga medis terkait pentingnya pemeriksaan tersebut.
5. **Monitoring dan Evaluasi Berkala**
Melaksanakan monitoring secara berkala terhadap tren jumlah pemeriksaan setiap bulan guna mengidentifikasi pola peningkatan atau penurunan serta sebagai dasar pengambilan keputusan selanjutnya.
6. **Peningkatan Mutu Pelayanan**
Tetap mempertahankan kualitas pelayanan yang telah mencapai target dengan melakukan pengawasan mutu internal secara konsisten dan berkelanjutan.

3.1.1 Rujukan Laboratorium Keluar

Pemeriksaan	Maret	April	Mei
D dimer	1	3	1
ANA test	1	0	0
Hb Elektroforesis	0	1	0
Gamma GT	1	1	0
Anti Hbs Elisa	0	1	0
Alkali Fosfatase	0	1	0
IgM Anti HAV	1	0	0
IgG/M dengue	0	1	1
NS one	0	1	1
IgE	0	1	0
VDRL	1	1	1
TPHA	2	7	1
IgG CMV	0	0	1
IgM CMV	0	0	1
IgG toxoplasma	1	1	4
IgM toxoplasma	1	1	4
IgM Rubella	0	0	1
IgG Rubella	0	0	1
CD-4	0	1	1
ASTO	1	1	3
Kultur Pus	0	0	1
Kultur BTA (Sputum)	1	1	0
Kultur Urine	2	1	1
Kultur Darah	0	2	0
Rectal Swab	0	0	1
Pap Smear	3	7	2
A.F.P	0	2	0
C.E.A	0	2	0

PSA	0	1	0
CA 125	0	1	0
CA 19-9	0	2	0
Sitologi Cairan Pleura	2	3	5
Analisa Cairan Pleura	2	5	6
Analisa Cairan Ascites	0	0	1
PA golongan 1	7	9	4
PA golongan 2	1	5	5
PA golongan 3	53	103	84
Total	81	166	131

Analisa:

Total rujukan laboratorium keluar pada bulan Maret sebanyak 81 pemeriksaan, mengalami peningkatan signifikan pada bulan April menjadi 166 pemeriksaan, kemudian menurun pada bulan Mei menjadi 131 pemeriksaan. Meskipun terjadi penurunan pada bulan Mei, jumlah tersebut masih lebih tinggi dibandingkan bulan Maret.

1. Pemeriksaan dengan Frekuensi Tinggi

Pemeriksaan yang paling sering dirujuk adalah:

- PA Golongan 3, dengan jumlah tertinggi pada bulan April (103) dan tetap tinggi pada bulan Mei (84)
- PA Golongan 1 dan 2, yang juga menunjukkan kontribusi cukup signifikan
- Analisa cairan pleura dan sitologi cairan pleura, yang mengalami peningkatan pada bulan Mei

Hal ini menunjukkan tingginya kebutuhan pemeriksaan patologi anatomi dan analisa cairan yang belum dapat sepenuhnya dilayani di laboratorium internal.

2. Tren Peningkatan Pemeriksaan Tertentu

Beberapa pemeriksaan mengalami peningkatan pada bulan Mei, antara lain:

- IgG dan IgM Toxoplasma
- ASTO
- Analisa cairan pleura dan ascites
- Pemeriksaan CMV dan Rubella (mulai muncul pada bulan Mei)

Peningkatan ini dapat mengindikasikan adanya peningkatan kasus infeksi atau kebutuhan diagnostik yang lebih spesifik.

3. Tren Penurunan Pemeriksaan

Beberapa pemeriksaan mengalami penurunan atau tidak lagi dirujuk pada bulan Mei, seperti:

- a. Pemeriksaan tumor marker (AFP, CEA, CA 125, CA 19-9, PSA)
- b. Gamma GT dan beberapa parameter kimia klinik lainnya
- c. Kultur darah dan kultur BTA

4. Stabilitas Pemeriksaan

Pemeriksaan seperti VDRL dan beberapa kultur menunjukkan jumlah yang relatif stabil, menandakan kebutuhan rutin yang konsisten.

5. Interpretasi Umum

Fluktuasi jumlah rujukan laboratorium keluar menunjukkan adanya dinamika kebutuhan pemeriksaan yang dipengaruhi oleh pola penyakit, ketersediaan fasilitas internal, serta permintaan klinis. Tingginya rujukan pada pemeriksaan tertentu, khususnya patologi anatomi dan analisa cairan, menunjukkan adanya keterbatasan layanan internal pada parameter tersebut.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, terjadi peningkatan signifikan rujukan laboratorium pada bulan April yang kemudian diikuti penurunan pada bulan Mei, namun masih berada di atas jumlah bulan Maret. Pemeriksaan patologi anatomi dan analisa cairan menjadi kontributor utama rujukan. Diperlukan evaluasi lebih lanjut terkait kapasitas pelayanan internal guna mengurangi ketergantungan terhadap rujukan eksternal serta meningkatkan efisiensi pelayanan laboratorium.

3.2. PME dan PMI

Tabel 3.2.1 Pemantapan Mutu Externel

No	PME	TANGGAL	ALAT	HASIL
1	Proses Pengerjaan PME tahun 2026	5-6 Mei pengerjaan 1 siklus 1	Alat DL (Beckman Dxh 500)	Hasil sudah di masukan ke Link PME
		20-21 Mei Pengerjaan 2 Siklus 1	Alat Kimia Klinik (Thermo indiko)	Hasil sudah di masukan ke Link PME
			Poct (Stick GDA)	Hasil sudah di masukan ke Link PME
			Faal Hemosasis (Thrombothemer)	Hasil sudah di masukan ke Link PME

Analisis : Proses pengerjaan PME Siklus Pertama sudah dilakukan pada tanggal 5-6 Mei dan pengerjaan kedua Dilakukan pada tanggal 20-21 Mei, untuk penginputan hasil PME siklus pertama pengerjaan satu dilakukan pada tanggal 13 Mei, Untuk penginputan hasil PME siklus pertama pengerjaan kedua di lakukan pada tanggal 25 Mei.

Tabel 3.2.2 Pemantapan Mutu Internal

No	Nama Alat	QC masuk	QC Tidak masuk	Keterangan
1	URIT/5160	Selama bulan April kontrol DL tidak datang	-	Alat minta di kalibrasi, kalibrasi sudah dilakukan pada tanggal 29 Juli
2	Thermo Indiko	QC alat Indiko di bulan Mei stabil masuk semua	-	Bahan kontrol stabil
3	Mini Vidas	Kontrol tidak ada masalah	-	Kontrol Selalu Masuk
4	Gems 3500	CVP dan Cadrige Tidak Ada Masalah	-	Kontrol Selalu Masuk
5	Trombo timer	Reagen Control Tidak ada masalah	-	Kontrol Selau masuk
6	Abbot Alfinion	Reagen Control Tidak Ada masalah	-	Kontrol Selalu masuk

Analisis: Berdasarkan hasil pemantauan Quality Control (QC) alat laboratorium selama bulan Mei, secara umum seluruh alat menunjukkan kondisi **baik dan stabil**, dengan sebagian besar parameter kontrol berada dalam rentang yang dapat diterima.

Namun, terdapat satu alat yang mengalami kendala yaitu:

- URIT/5160**, dimana kontrol (DL) sudah tersedia selama bulan Mei, tetapi **tidak masuk (out of range)**. Hal ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian hasil kontrol yang dapat mempengaruhi validitas hasil pemeriksaan. Sementara itu, alat lainnya seperti:
- Thermo Indiko**
- Mini Vidas**
- Gems 3500**
- Trombo Timer**
- Abbott Alfinion**

menunjukkan hasil QC yang **stabil dan selalu masuk dalam rentang kontrol**, baik dari sisi bahan kontrol maupun performa alat. Hal ini menandakan bahwa proses pemeriksaan pada alat-alat tersebut dapat berjalan dengan baik dan hasil yang dihasilkan dapat dipercaya.

RTL: Sebagai tindak lanjut terhadap hasil QC bulan Mei, khususnya pada alat URIT/5160 yang menunjukkan hasil kontrol tidak masuk, sudah menghubungi teknis alat. Selanjutnya akan

dilakukan monitoring ketat terhadap hasil QC pasca kalibrasi untuk memastikan alat kembali dalam kondisi terkendali.

Selain itu, dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kemungkinan faktor penyebab, termasuk kondisi reagen, alat, maupun prosedur operasional. Untuk menjaga mutu pelayanan, dilakukan pula monitoring rutin terhadap seluruh alat serta penjadwalan kalibrasi dan maintenance secara berkala guna mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

Tabel 3.2.3 MCU

	Tanggal	Nama Perusahaan	Jumlah Pasien	Jenis Pemeriksaan
1	-	-	-	-

Analisis :

Berdasarkan data kerja sama pemeriksaan laboratorium dengan pihak perusahaan, pada periode pelaporan **tidak terdapat kegiatan atau kunjungan pasien dari perusahaan (0 data)**. Tidak adanya data tanggal, nama perusahaan, jumlah pasien, maupun jenis pemeriksaan menunjukkan bahwa:

- Tidak ada kerja sama aktif** dengan pihak perusahaan selama periode tersebut, atau
- Kerja sama ada namun **belum terealisasi dalam bentuk pelayanan**, atau
- Belum dilakukan **pencatatan/dokumentasi kegiatan** secara optimal

Kondisi ini mengindikasikan bahwa **kontribusi layanan laboratorium dari segmen perusahaan masih belum berjalan atau belum optimal**, sehingga berpotensi mempengaruhi capaian pemanfaatan layanan (utilitas).

RTL:

- Pengembangan Kerja Sama (MoU) dengan Perusahaan**
Melakukan pendekatan dan promosi kepada perusahaan/instansi untuk menjalin kerja sama pemeriksaan laboratorium.
- Optimalisasi Promosi Layanan**
Meningkatkan sosialisasi paket medical check-up atau pemeriksaan laboratorium kepada pihak perusahaan.
- Peningkatan Sistem Pencatatan dan Pelaporan**
Memastikan seluruh kegiatan kerja sama terdokumentasi dengan baik dan tercatat dalam laporan.

4. **Koordinasi dengan Manajemen/Pemasaran**

Bekerja sama dengan bagian pemasaran rumah sakit untuk menjaring mitra perusahaan.

5. **Monitoring dan Evaluasi Berkala**

Melakukan evaluasi rutin terhadap perkembangan kerja sama dan jumlah kunjungan pasien dari perusahaan.

Kesimpulan

Selama periode pelaporan, tidak terdapat kegiatan pemeriksaan laboratorium dari pihak perusahaan, sehingga menunjukkan bahwa kerja sama eksternal belum berjalan atau belum optimal. Diperlukan upaya strategis dalam pengembangan kerja sama dan **peningkatan** promosi guna meningkatkan pemanfaatan layanan laboratorium dari segmen perusahaan.

Tabel 3.2.4. Nilai Kritis

No	Bulan	Jumlah nilai kritis	Presentase yang dilaporkan	Presentase yang tidak di laporkan
1	Januari	173	100%	0%
2	Februari	165	100%	0%
3	Maret	173	100%	0%
4	April	183	100%	0%
5	Mei	156	100%	0%
6				

Analisa: Berdasarkan data nilai kritis periode Januari sampai dengan Mei, jumlah nilai kritis yang ditemukan setiap bulan mengalami fluktuasi, yaitu pada bulan Januari sebanyak 173 kasus, Februari 165 kasus, Maret 173 kasus, April 183 kasus, dan Mei 156 kasus. Meskipun terjadi variasi jumlah kasus setiap bulan, seluruh nilai kritis yang ditemukan telah dilaporkan dengan persentase pelaporan mencapai 100%, dan tidak terdapat nilai kritis yang tidak dilaporkan.

Capaian ini menunjukkan bahwa sistem pelaporan nilai kritis di laboratorium telah berjalan dengan sangat baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kepatuhan petugas dalam melakukan pelaporan juga menunjukkan konsistensi yang tinggi. Fluktuasi jumlah nilai kritis yang terjadi kemungkinan dipengaruhi oleh variasi jumlah pasien, jenis kasus klinis, serta tingkat kunjungan pasien pada masing-masing bulan.

RTL : Untuk mempertahankan capaian yang telah baik ini, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap pelaporan nilai kritis setiap bulan. Selain itu, perlu dipastikan bahwa seluruh proses pelaporan terdokumentasi dengan lengkap, termasuk waktu pelaporan, identitas petugas, dan pihak penerima laporan.

Peningkatan kompetensi petugas juga perlu dilakukan melalui kegiatan pelatihan atau refresh terkait prosedur pelaporan nilai kritis sesuai standar operasional prosedur yang

berlaku. Evaluasi terhadap tren jumlah nilai kritis juga perlu dilakukan secara berkala guna mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan atau penurunan kasus.

Apabila tersedia sistem informasi laboratorium, optimalisasi penggunaan sistem tersebut sebagai pengingat atau alarm pelaporan nilai kritis perlu ditingkatkan guna mencegah keterlambatan pelaporan.

Kesimpulan: Pelaporan nilai kritis periode Januari sampai dengan Mei telah mencapai target dengan persentase 100% dan tidak ditemukan kasus yang tidak dilaporkan. Hal ini menunjukkan bahwa mutu pelayanan laboratorium dalam aspek pelaporan nilai kritis telah terpenuhi dengan baik. Meskipun demikian, monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan tetap diperlukan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan.

3.2.5 Kerusakan sampel Bulan Mei

No	Tgl	Nama Pasien	No.RM	Unit	Jenis Spesimen	Pemeriksaan	Alasan Penolakan	Tindakan
1	1/5/2026	MUHAMMAD NUR YASIN	191485	4A	DARAH	ELEKTROLIT	LISIS	MINTA SAMPEL ULANG
2	7/5/2026	NABILA ZAHROTUL	081846	IGD	DARAH	DL	CLOTTING	MINTA SAMPEL ULANG
3	8/5/2026	MAIMUNAH WINARTY HENKY	244644	IGD	DARAH	ELEKTROLIT-BGA	SAMPEL VENA	MINTA SAMPEL ULANG
4	8/5/2026	IGNATIA	142054	4A	DARAH	DL	CLOTTING	MINTA SAMPEL ULANG
5	9/5/2026	ARFAN FAHMI	248975	IGD	DARAH	DL	CLOTTING	MINTA SAMPEL ULANG
6	9/5/2026	TAUFIK HIDAYAT	116512	IGD	DARAH	DL	CLOTTING	MINTA SAMPEL ULANG
7	15/5/2026	DJUPRI	207530	IGD	DARAH	DL	CLOTTING	MINTA SAMPEL ULANG

8	17/5/2026	KUSIATI	249368	IGD	DARAH	DL	CLOTTING	MINTA SAMPEL ULANG
9	21/5/2026	NUWAIRA SHANUM	166583	IGD	DARAH	DL	CLOTTING	MINTA SAMPEL ULANG
10	27/05/2026	WAGINI	154248	ICU	DARAH	HBA1C	CLOTTING	MINTA SAMPEL ULANG
11	28/05/2026	DANAR ARIFU S	249872	IGD	DARAH	FH	LISIS, KURANG DARI 1CC	MINTA SAMPEL ULANG
12	29/05/2026	WIWIK	053066	IGD	DARAH	ELEKTROLIT-BGA	SAMPEL VENA	MINTA SAMPEL ULANG
13	29/05/2026	TITIK H	249892	IGD	DARAH	ELEKTROLIT-BGA	SAMPEL VENA	MINTA SAMPEL ULANG
14	29/05/2026	SUWANDI	183152	ICU	DARAH	ELEKTROLIT	LISIS	MINTA SAMPEL ULANG
15	29/05/2026	LESTARI NINGSIH	082707	IGD	DARAH	DL	CLOTTING	MINTA SAMPEL ULANG
16	31/05/2026	SAIULLILLAH HANDAYANI	250045	IGD	DARAH	DL	CLOTTING	MINTA SAMPEL ULANG
17	31/05/2026	RUSTIN		IGD	DARAH	DL	CLOTTING	MINTA SAMPEL ULANG

Analisa:

Berdasarkan data penolakan sampel laboratorium selama bulan Mei 2026, tercatat sebanyak 17 kejadian penolakan sampel yang seluruhnya berasal dari spesimen darah dengan berbagai jenis pemeriksaan.

1. Gambaran Umum Penolakan

Seluruh sampel yang ditolak memerlukan tindakan berupa permintaan pengambilan sampel ulang. Hal ini menunjukkan bahwa penolakan berdampak langsung terhadap keterlambatan pelayanan serta ketidaknyamanan pasien.

2. Jenis Pemeriksaan yang Ditolak

Pemeriksaan yang paling sering mengalami penolakan adalah:

- a. Darah Lengkap (DL) → paling dominan

- b. Elektrolit dan Elektrolit-BGA
- c. HbA1c dan Fungsi Hati (FH)

Hal ini menunjukkan bahwa pemeriksaan rutin masih memiliki tingkat kesalahan pre-analitik yang cukup tinggi.

1. Alasan Penolakan Sampel

Penyebab utama penolakan meliputi:

- a. Clotting (pembekuan sampel) → penyebab terbanyak
- b. Lisis (hemolisis)
- c. Jenis sampel tidak sesuai (sampel vena untuk BGA)
- d. Volume sampel tidak mencukupi

Kondisi tersebut mengindikasikan adanya ketidaksesuaian prosedur dalam tahap pengambilan dan penanganan sampel.

2. Distribusi Unit Pengirim

Sebagian besar penolakan berasal dari:

- a. IGD (Instalasi Gawat Darurat) → paling dominan
- b. Disusul oleh ruang rawat (4A) dan ICU

Tingginya angka penolakan di IGD kemungkinan dipengaruhi oleh kondisi kerja yang cepat dan tekanan tinggi sehingga berpotensi meningkatkan kesalahan pre-analitik.

Interpretasi

Penolakan sampel pada bulan Mei 2026 didominasi oleh kesalahan pada tahap pre-analitik, khususnya dalam proses pengambilan, penanganan, dan pengiriman sampel. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) guna meminimalkan kesalahan.

RTL :

1. **Peningkatan Kepatuhan terhadap SOP Pengambilan Sampel**
Melakukan sosialisasi dan penegasan kembali standar operasional prosedur pengambilan dan penanganan sampel kepada seluruh petugas terkait, khususnya pada unit IGD dan ICU.
2. **Pelatihan dan Edukasi Petugas**
Menyelenggarakan pelatihan berkala mengenai teknik pengambilan sampel yang benar, termasuk pencegahan clotting, hemolisis, serta pemilihan jenis spesimen yang sesuai dengan pemeriksaan.
3. **Monitoring dan Evaluasi Berkala**
Melakukan pemantauan rutin terhadap angka penolakan sampel setiap bulan serta evaluasi penyebab untuk mencegah kejadian berulang.

4. **Peningkatan Koordinasi Antar Unit**
Memperkuat komunikasi antara laboratorium dan unit pengirim terkait kesesuaian spesimen dan persyaratan pemeriksaan.
5. **Penerapan Sistem Peringatan Dini**
Memberikan umpan balik langsung kepada unit pengirim setiap terjadi penolakan sampel sebagai bentuk evaluasi dan pembelajaran.
6. **Pengawasan Mutu Pre-Analitik**
Meningkatkan pengawasan pada tahap pre-analitik sebagai bagian dari program manajemen mutu laboratorium guna menurunkan angka penolakan sampel.

Kesimpulan

Penolakan sampel laboratorium pada bulan Mei 2026 masih didominasi oleh kesalahan pre-analitik yang dapat dicegah. Dengan pelaksanaan rencana tindak lanjut yang sistematis dan berkelanjutan, diharapkan angka penolakan sampel dapat ditekan sehingga mutu pelayanan laboratorium semakin meningkat.

3.2.6 Permintaan Labu darah

No	Bulan	Permintaan Labu darah				Total Permintaan Labu darah
		A	AB	O	B	
1	Januari	21	6	24	29	80
2	Februari	16	27	37	7	87
3	Maret	33	11	57	40	141
4	April	15	32	30	7	84
5	Mei	21	11	24	22	78
6	Juni					
7	Juli					
8	Agustus					
9	September					
10	Oktober					
11	November					

Analisis: Berdasarkan data permintaan labu darah selama periode Januari hingga Mei 2026, diperoleh gambaran sebagai berikut:

1. Gambaran Umum

Total permintaan labu darah menunjukkan fluktuasi setiap bulan, yaitu:

- a. Januari: 80
- b. Februari: 87
- c. Maret: 141 (tertinggi)
- d. April: 84

- e. Mei: 78 (terendah)

Terjadi peningkatan signifikan pada bulan Maret, kemudian mengalami penurunan kembali pada bulan April dan Mei.

2. Distribusi Berdasarkan Golongan Darah

- a. **Golongan darah O dan B** merupakan yang paling sering diminta secara keseluruhan.
- b. **Golongan darah AB** memiliki jumlah permintaan paling rendah.
- c. Pada bulan Maret, terjadi peningkatan pada hampir semua golongan darah, terutama golongan darah B (57) dan O (40).

3. Tren Permintaan

- a. Peningkatan tajam pada bulan Maret kemungkinan berkaitan dengan meningkatnya kebutuhan transfusi, baik karena kasus gawat darurat, tindakan operasi, maupun kondisi pasien tertentu.
- b. Penurunan pada bulan April dan Mei menunjukkan adanya penurunan kebutuhan atau stabilisasi pelayanan klinis.

4. Interpretasi

Fluktuasi permintaan labu darah menunjukkan adanya variasi kebutuhan transfusi yang dipengaruhi oleh jumlah pasien, jenis kasus, serta aktivitas pelayanan medis. Tingginya permintaan pada bulan tertentu perlu diantisipasi untuk menjaga ketersediaan stok darah yang memadai.

RTL :

1. Perencanaan Kebutuhan Stok Darah

Melakukan perencanaan kebutuhan stok darah berdasarkan tren permintaan bulanan, khususnya mengantisipasi peningkatan pada periode tertentu seperti yang terjadi pada bulan Maret.

2. Peningkatan Koordinasi dengan Bank Darah/UTD

Memperkuat koordinasi dengan Unit Transfusi Darah (UTD) untuk memastikan ketersediaan stok darah sesuai dengan kebutuhan pelayanan.

3. Monitoring dan Evaluasi Berkala

Melakukan pemantauan rutin terhadap permintaan labu darah setiap bulan guna mendeteksi tren peningkatan atau penurunan secara dini.

4. Optimalisasi Manajemen Stok

Mengatur distribusi dan penggunaan stok darah secara efisien untuk menghindari kekurangan maupun kelebihan stok yang berpotensi menyebabkan kedaluwarsa.

5. Peningkatan Kewaspadaan pada Golongan Darah Tertentu

Memberikan perhatian khusus pada golongan darah dengan permintaan tinggi seperti golongan O dan B, dengan memastikan ketersediaan stok yang lebih memadai.

6. Evaluasi Klinis Penggunaan Darah

Berkoordinasi dengan tenaga medis untuk memastikan penggunaan darah sesuai indikasi medis sehingga penggunaan lebih rasional dan efisien.

Kesimpulan

Permintaan labu darah selama periode Januari hingga Mei 2026 menunjukkan pola fluktuatif dengan puncak pada bulan Maret. Diperlukan perencanaan dan pengelolaan stok darah yang optimal serta koordinasi yang baik dengan pihak terkait guna menjamin ketersediaan darah dan kelancaran pelayanan transfusi.

3.2.7. Permintaan Return Labu darah

No	Bulan	Permintaan Return Labu darah				Total Permintaan Labu darah
		A	AB	O	B	
1	Januari	4	1	4	2	11
2	Februari	2	6	0	0	8
3	Maret	14	11	20	20	65
4	April	-	2	4	-	6
5	Mei	2	7	6	5	15
6	Juni					
7	Juli					
8	Agustus					
9	September					
10	Oktober					
11	November					
12	Desember					

Analisis: Berdasarkan data return labu darah selama periode Januari hingga Mei 2026, diperoleh gambaran sebagai berikut:

1. Gambaran Umum

Total return labu darah menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan, yaitu:

- Januari: 11
- Februari: 8
- Maret: 65 (tertinggi)
- April: 6 (terendah)
- Mei: 15

Terjadi lonjakan tajam pada bulan Maret, kemudian menurun drastis pada bulan April, dan kembali meningkat pada bulan Mei.

2. Distribusi Berdasarkan Golongan Darah

- a. Pada bulan Maret, seluruh golongan darah mengalami peningkatan return yang signifikan, terutama golongan darah **O dan B (masing-masing 20)** serta **A (14)**.
- b. Pada bulan Mei, return relatif merata pada semua golongan darah, dengan dominasi pada golongan **AB (7)** dan **O (6)**.
- c. Pada bulan April, data menunjukkan angka yang rendah, bahkan terdapat golongan darah dengan nilai nol (tidak ada return).

3. Tren Return

- a. Lonjakan pada bulan Maret mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara permintaan dan penggunaan darah, seperti pembatalan tindakan medis, perubahan kondisi pasien, atau perencanaan transfusi yang kurang optimal.
- b. Penurunan drastis pada bulan April menunjukkan adanya perbaikan dalam pengelolaan penggunaan darah.
- c. Peningkatan kembali pada bulan Mei perlu menjadi perhatian untuk mencegah terulangnya ketidakefisienan.

4. Interpretasi

Tingginya angka return labu darah, terutama pada bulan Maret, menunjukkan masih adanya ketidakefisienan dalam perencanaan dan penggunaan darah. Return yang tinggi berpotensi meningkatkan risiko pemborosan serta mempengaruhi kualitas darah apabila tidak dikelola dengan baik.

RTL :

1. Evaluasi Permintaan dan Penggunaan Darah

Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara permintaan dan realisasi penggunaan darah, khususnya pada bulan dengan angka return tinggi.

2. Peningkatan Koordinasi dengan Unit Klinis

Meningkatkan komunikasi dengan dokter dan unit pelayanan terkait untuk memastikan permintaan darah dilakukan sesuai kebutuhan klinis yang aktual.

3. Penerapan Permintaan Darah yang Rasional

Mendorong penerapan prinsip penggunaan darah secara rasional (patient blood management) untuk meminimalkan permintaan yang tidak diperlukan.

4. Monitoring dan Evaluasi Berkala

Melakukan pemantauan rutin terhadap angka return darah setiap bulan serta menjadikan data tersebut sebagai indikator mutu pelayanan.

5. Optimalisasi Manajemen Stok Darah

Mengatur distribusi dan pengembalian darah secara tepat waktu agar kualitas darah tetap terjaga dan dapat digunakan kembali bila masih memenuhi syarat.

6. Peningkatan Edukasi Tenaga Medis

Memberikan edukasi kepada tenaga medis terkait pentingnya perencanaan transfusi yang tepat guna mengurangi angka return.

Kesimpulan

Return labu darah selama periode Januari hingga Mei 2026 menunjukkan pola fluktuatif dengan lonjakan signifikan pada bulan Maret. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan efisiensi dalam perencanaan dan penggunaan darah. Dengan pelaksanaan rencana tindak lanjut yang tepat, diharapkan angka return dapat ditekan dan pengelolaan darah menjadi lebih optimal.

3.2.8. Hasil Incompatible pada Crossmatch pada bulan Mei

No		Jumlah pasien dan permintaan labu darah Incom				Total Permintaan Labu darah
		A	AB	O	B	
1	-	-	-	-	-	-

Analisis: Berdasarkan data hasil pemeriksaan crossmatch pada bulan Mei 2026, tidak ditemukan adanya kasus inkompatibilitas (incompatible) pada seluruh pemeriksaan yang dilakukan. Jumlah pasien maupun permintaan labu darah dengan hasil incompatible tercatat **nihil (0 kasus)**.

1. Gambaran Umum

Seluruh pemeriksaan crossmatch yang dilakukan pada bulan Juli menunjukkan hasil kompatibel (compatible), sehingga tidak terdapat penolakan atau ketidaksesuaian antara darah donor dan resipien.

2. Interpretasi

Tidak ditemukannya kasus incompatible menunjukkan bahwa proses:

- Identifikasi pasien
- Penentuan golongan darah
- Uji serasi (crossmatch)
- Prosedur pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik

telah berjalan dengan baik sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.

3. Makna Klinis dan Mutu Pelayanan

Kondisi ini mencerminkan:

- Tingginya ketepatan pemeriksaan imunoserologi
- Baiknya kualitas reagen dan alat yang digunakan
- Kepatuhan petugas terhadap prosedur kerja
- Minimnya risiko reaksi transfusi akibat inkompatibilitas

Dengan demikian, mutu pelayanan transfusi darah pada periode ini dapat dikategorikan **baik**.

RTL :

Mempertahankan Kepatuhan terhadap SOP
Tetap memastikan seluruh tahapan pemeriksaan crossmatch dilakukan sesuai standar untuk menjaga hasil yang konsisten dan akurat.

1. Monitoring dan Evaluasi Berkala

Melakukan pemantauan rutin terhadap hasil crossmatch setiap bulan sebagai bagian dari indikator mutu pelayanan laboratorium.

2. Penguatan Quality Control (QC)

Menjaga konsistensi pelaksanaan kontrol mutu internal serta kalibrasi alat untuk memastikan keakuratan hasil pemeriksaan.

3. Peningkatan Kompetensi Petugas

Melakukan pelatihan dan refreshment bagi petugas laboratorium terkait prosedur imunoserologi dan transfusi darah.

4. Audit Internal Secara Berkala

Melakukan audit terhadap proses pelayanan transfusi guna memastikan tidak terdapat potensi kesalahan yang tidak terdeteksi.

5. Kewaspadaan terhadap Potensi Risiko

Meskipun tidak ditemukan kasus incompatible, tetap diperlukan kewaspadaan terhadap kemungkinan terjadinya reaksi transfusi akibat faktor lain.

Kesimpulan

Tidak ditemukan kasus incompatible pada pemeriksaan crossmatch bulan Juli 2026, yang menunjukkan bahwa pelayanan transfusi darah telah berjalan dengan baik dan sesuai standar. Upaya pemeliharaan mutu perlu terus dilakukan untuk mempertahankan kualitas pelayanan yang optimal.

3.8 Reagen

Tabel 3.8.1 Stock Penyediaan Reagen Laboratorium Mei

No	NAMA REAGEN	SUHU	ED	STOCK BULAN LALU	STOCK DATANG BULAN INI	PENGUNAAN BULAN INI	SISA
1	Albumin	2-8 C	31/12/2026	8 pcs	0 pcs	1 pcs	7 pcs
2	APTT	2-8 C	12/2026	10 pcs	0 pcs	2 pcs	8 pcs
3	Bilirubin Direct	2-8 C	31/11/2026	2 pcs	4 pcs	1 pcs	5 pcs
4	Bilirubin Total	2-8 C	31/11/2026	0 pcs	4 pcs	1 pcs	3 pcs

5	Cholesterol	2-8 C	31/12/2026	5 pcs	0 pcs	1 pcs	4 pcs
6	Creatinine	2-8 C	31/11/2026	7 pcs	8 pcs	5 pcs	10 pcs
7	eCal	2-8 C	28/02/2026	4 pcs	0 pcs	1 pcs	3 pcs
8	FT4N (Free T4)	2-8 C	31/12/2026	1 box	1 box	1 box	1 box
9	GEM Catridge	15-25 C	31/5/2026	1 box	1 box	1 box	1 box
10	GEM CVP	2-8 C	31/12/2026	1 box	1 box	1 box	1 box
11	Glucose	2-8 C	31/12/2026	9 pcs	16 pcs	8 pcs	15 pcs
12	HDL/LDL Calibrator	2-8 C	31/12/2026	5 pcs	0 pcs	1 pcs	4 pcs
13	HDL-Cholesterol	2-8 C	31/06/2026	5 pcs	0 pcs	0 pcs	5 pcs
14	LDL-Cholesterol	2-8 C	31/06/2026	9 pcs	8 pcs	8 pcs	9 pcs
15	Lipotrol	2-8 C	30/06/2026	3 pcs	5 pcs	3 pcs	5 pcs
16	Nortrol	2-8 C	30/06/2026	12 pcs	0 pcs	2 pcs	10 pcs
17	sCal	2-8 C	31/12/2027	8 pcs	0 pcs	2 pcs	6 pcs
18	SGOT (AST)	2-8 C	31/12/2026	6 pcs	0 pcs	2 pcs	4 pcs
19	SGPT (ALT)	2-8 C	31/12/2026	7 pcs	0 pcs	1 pcs	6 pcs
20	Thromboplastin L	2-8 C	31/12/2026	11 pcs	10 pcs	13 pcs	8 pcs
21	TNHS (Troponin)	2-8 C	31/12/2026	1 box	1 box	1 box	1 box
22	Total Protein Plus	2-8 C	31/12/2026	1 pcs	0 pcs	0 pcs	1 pcs
23	Triglycerides	2-8 C	31/03/2026	4 pcs	12 pcs	5 pcs	11 pcs
24	TSH	2-8 C	30/12/2026	1 box	1 box	1 box	1 box

25	Urea	2-8 C	30/06/2026	1 pcs	10 pcs	7 pcs	4 pcs
26	Uric Acid	2-8 C	31/08/2026	9 pcs	0 pcs	5 pcs	4 pcs
27	Washfluid	2-8 C	30/04/2026	8 pcs	0 pcs	2 pcs	6 pcs
28	Goldar Anti-A	2-8 C	12/2026	1 vial	1 vial	1 vial	1 vial
29	Goldar Anti-AB	2-8 C	12/2026	1 vial	1 vial	1 vial	1 vial
30	Goldar Anti-B	2-8 C	12/2026	1 vial	1 vial	1 vial	1 vial
31	Goldar Anti-D (Rhesus)	2-8 C	12/2026	1 vial	1 vial	1 vial	1 vial
32	HbsAg	< 30 C	12/2026	4 box	0 box	1 box	3 box
33	HCG	2-30 C	12/2026	7 box	0 box	1 box	6 box
34	Hepagusan (Heparin)	2-8 C	07/06/2026	11 vial	0	3	8
35	HbA1C	2-8 C	25/06/2026	5 box	9 box	11 box	3 box
36	HIV (Oncoprobe)	2-30 C	03/2027	1 box	1 box	1 box	1 box
37	RF (Rheumatoid Factor)	2-8 C	12/2026	1 box	1 box	1 box	1 box
38	Tuberculin	2-8 C	12/2026	7 vial	0 vial	0 vial	7 vial
39	Urinalysis	2-30 C	05/03/2026	10 box	0 box	2 box	8 box
40	Widal AO	2-8 C	10/2026	1 vial	1 vial	1 vial	1 vial
41	Widal BO	2-8 C	08/2027	1 vial	1 vial	1 vial	1 vial
42	Widal H	2-8 C	08/2027	1 vial	1 vial	1 vial	1 vial
43	Widal O	2-8 C	12/2027	1 vial	1 vial	1 vial	1 vial
44	Objek Glass 7101	< 30 C	09/2027	9 box	0 box	2 box	7 box
45	Sample Indiko	< 30 C	07/2027	1 bag	1 bag	1 bag	1 bag
46	Tabung EDTA (Ungu)	< 30 C	05/2027	14 pack	23 pack	21 pack	16 pack
47	Tabung Na Citrat (Biru)	10-35 C	10/2027	13 pack	0 pack	5 pack	8 pack
48	Tabung Plain (Merah)	< 30 C	05/2027	11 pack	21 pack	22 pack	10 pack
49	Tabung (Urine)	< 30 C	11/2028	1 bag	1 bag	1 bag	1 bag

50	Tencell Cuvette	14-60 C	31/07/2027	1 bag	1 bag	1 bag	1 bag
51	Tubex TF	2-8 C	05/08/2027	1 box	1 box	1 box	1 box
52	Yellow Tips	< 30 C	07/2027	8 bag	0 bag	1 bag	7 bag
53	DG sol	2-8 C	12/2027	2 vial	0 vial	1 vial	1 vial
54	Dg Gel Combs	2-8 C	12/2027	1 box	1 box	1 box	1 box
55	Rapid Narkoba 7 Par	<30 C	12/2027	1 box	1 box	1 box	1 box
56	Sput Terumo 3cc	<30 C	12/2027	4 box	12 box	13 box	3 box
57	Sput Terumo 10cc	<30 C	12/2027	1 box	0 box	1 box	0 box
58	Sput Terumo 1cc	<30 C	12/2027	1 box	1 box	1 box	1 box
59	Sput Terumo 5cc	<30 C	12/2026	2 box	0 box	1 box	1 box
60	Blue Tipe	< 30 C	12/2026	4 box	2 box	4 box	2 box

Analisa: Mengenai stok penyediaan reagen laboratorium bulan Mei 2026, diperoleh hasil analisis sebagai berikut:

1. Gambaran Umum

Secara umum, ketersediaan reagen laboratorium dalam kondisi **cukup dan terkendali**, dengan sebagian besar item memiliki sisa stok yang masih mampu menunjang pelayanan pemeriksaan laboratorium.

2. Penggunaan Reagen

Penggunaan reagen menunjukkan variasi sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan, dengan kategori:

- Penggunaan tinggi:** Glucose, Creatinine, Thromboplastin L, HbA1C, serta tabung EDTA dan tabung plain.
- Penggunaan sedang:** Urea, Triglycerides, Uric Acid, SGOT, SGPT.
- Penggunaan rendah atau tidak digunakan:** HDL-Cholesterol, Total Protein Plus, Tuberculin.

Hal ini mencerminkan pola permintaan pemeriksaan pasien selama periode tersebut.

3. Kondisi Stok Kritis

Ditemukan beberapa item yang perlu perhatian khusus:

- Stok habis (0):**
 - Sput Terumo 10cc
- Stok minimal (berisiko habis):**
 - DG Sol (1 vial)
 - Total Protein Plus (1 pcs)

Kondisi ini berpotensi menghambat pelayanan apabila tidak segera dilakukan pengadaan.

4. Reagen Mendekati Expired Date (ED)

Beberapa reagen memiliki masa kedaluwarsa dalam waktu dekat, antara lain:

- a. HbA1C (Juni 2026)
- b. Hepagusan/Heparin (Juni 2026)
- c. Lipotrol dan Nortrol (Juni 2026)
- d. HDL dan LDL Cholesterol (Juni 2026)
- e. Urea (Juni 2026)

Reagen tersebut perlu segera digunakan secara optimal untuk menghindari kerugian akibat kedaluwarsa.

5. Kesesuaian Stok dan Distribusi

Sebagian besar reagen menunjukkan keseimbangan antara stok masuk, penggunaan, dan sisa. Namun terdapat:

- a. **Overstock** pada beberapa item dengan penggunaan rendah
- b. **Fast moving** pada item tertentu yang perlu perencanaan pengadaan lebih intensif

RTL: Pengadaan Segera untuk Stok Kritis

Melakukan pemesanan segera terhadap reagen atau bahan habis pakai yang stoknya kosong atau mendekati habis, terutama yang berpengaruh terhadap pelayanan utama.

- 1) **Optimalisasi Sistem FEFO (First Expired First Out)**
Mengutamakan penggunaan reagen dengan masa kedaluwarsa terdekat guna meminimalkan risiko kerugian.
- 2) **Perencanaan Kebutuhan Berbasis Konsumsi**
Menyusun perencanaan pengadaan berdasarkan data pemakaian bulanan agar lebih akurat dan efisien.
- 3) **Monitoring dan Evaluasi Stok Berkala**
Melakukan pengecekan stok secara rutin (mingguan/bulanan) untuk memastikan ketersediaan dan kondisi reagen tetap optimal.
- 4) **Pengendalian Overstock**
Mengurangi pengadaan pada reagen dengan penggunaan rendah dan stok masih tinggi.
- 5) **Koordinasi dengan Unit Pengadaan**
Meningkatkan komunikasi terkait waktu pemesanan dan distribusi untuk mencegah keterlambatan suplai.
- 6) **Peningkatan Ketelitian Pencatatan**
Memastikan seluruh data stok, penggunaan, dan sisa tercatat secara akurat sebagai dasar evaluasi dan perencanaan.

Kesimpulan

Pengelolaan stok reagen laboratorium bulan Mei 2026 secara umum berjalan baik dan terkendali. Namun demikian, masih terdapat beberapa item dengan stok kritis dan reagen mendekati masa kedaluwarsa yang memerlukan perhatian khusus agar pelayanan laboratorium tetap optimal dan berkesinambungan.

3.10 Pemeriksaan ECG

Tabel 3.10.1 Utilitas Penggunaan alat ECG

No	Nama alat	Bulan	Utilitas
1	Mindray	Januari	577 Test
2	Mindray	Februari	466 Test
3	Mindray	Maret	480 Test
4	Mindray	April	621 Test
5	Mindray	Mei	481 Test
6	Mindray	Juni	
7	Mindray	Juli	
8	Mindray	Agustus	
9	Mindray	September	
10	Mindray	Oktober	
11	Mindray	November	

Analisa: Berdasarkan data utilitas alat Mindray selama periode Januari hingga Mei 2026, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Gambaran Umum Utilitas

Jumlah pemeriksaan yang dilakukan menggunakan alat Mindray menunjukkan fluktuasi setiap bulan, yaitu:

- Januari: 577 test
- Februari: 466 test
- Maret: 480 test
- April: 621 test
- Mei: 481 test

Jumlah pemeriksaan tertinggi terjadi pada bulan April (621 test), sedangkan terendah pada bulan Februari (466 test).

2. Tren Penggunaan

Secara umum, penggunaan alat cenderung:

- a. Mengalami penurunan dari Januari ke Februari
- b. Relatif stabil pada bulan Februari–Maret
- c. Mengalami peningkatan signifikan pada bulan April
- d. Kembali menurun pada bulan Mei

Fluktuasi ini kemungkinan dipengaruhi oleh jumlah kunjungan pasien, permintaan pemeriksaan laboratorium, serta faktor operasional lainnya.

3. Evaluasi Kinerja Alat

Dengan rata-rata penggunaan sekitar 500–600 pemeriksaan per bulan, alat Mindray masih dalam kategori utilisasi baik dan optimal, serta mampu mendukung pelayanan laboratorium secara efektif.

Namun demikian, belum terdapat data pada bulan Juni hingga November, sehingga evaluasi tahunan belum dapat dilakukan secara menyeluruh.

RTL:

1. **Monitoring Utilitas Secara Berkala**
Melakukan pencatatan dan evaluasi penggunaan alat setiap bulan secara konsisten hingga akhir tahun.
2. **Analisis Tren Tahunan**
Mengumpulkan data lengkap selama 12 bulan untuk mengetahui pola penggunaan alat secara menyeluruh.
3. **Optimalisasi Pemanfaatan Alat**
Meningkatkan pemanfaatan alat melalui optimalisasi pelayanan pemeriksaan, terutama pada bulan dengan utilitas rendah.
4. **Pemeliharaan dan Kalibrasi Rutin**
Melakukan maintenance dan kalibrasi alat secara berkala untuk menjaga performa dan keakuratan hasil pemeriksaan.
5. **Evaluasi Faktor Fluktuasi**
Mengidentifikasi faktor penyebab naik turunnya jumlah pemeriksaan, seperti jumlah pasien, jenis layanan, atau kendala operasional.
6. **Perencanaan Kapasitas Alat**
Menggunakan data utilitas sebagai dasar dalam perencanaan kapasitas alat dan pengembangan layanan laboratorium.

Kesimpulan:

Utilitas alat Mindray selama periode Januari hingga Mei 2026 menunjukkan pola fluktuatif namun masih dalam batas optimal. Diperlukan monitoring lanjutan dan evaluasi berkala

untuk memastikan pemanfaatan alat tetap maksimal serta mendukung peningkatan mutu pelayanan laboratorium.

BAB III

MANAJEMEN FASILITAS DAN KESELAMATAN DAN K3

3.1 MFK

Tabel 4.1.1 Kegiatan MFK di laboratorium

No	Kegiatan Pokok	Ket.
1	Klasifikasi Inventaris	Klasifikasi alat laboratorium sudah dilakukan oleh pihak MFK
2	Kalibrasi	Kalibrasi alat lab dilakukan oleh vendor luar pada tanggal 16 maret 2026 berlaku sampai 16 maret 2027
3	Penambahan alat	Pada Bulan april di lakukan pemasangan LIS di laboratorium
4	Penggantian alat	Tidak ada pergantian alat
5	Perbaikan alat	Tidak ada perbaikan alat di laboratorium
6	Pemeliharaan alat	Selalu di lakukan kalibrasi setiap 3 bulan sekali oleh Vendor

Analisis :

Berdasarkan data kegiatan MFK di laboratorium, diperoleh hasil analisis sebagai berikut:

1. Klasifikasi Inventaris

Klasifikasi alat laboratorium telah dilakukan oleh pihak MFK. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan aset telah berjalan dengan baik dan terdata secara sistematis.

2. Kalibrasi Alat

Kalibrasi alat laboratorium telah dilaksanakan oleh vendor eksternal pada tanggal 16 Maret 2026 dan berlaku hingga 16 Maret 2027. Hal ini menunjukkan bahwa alat telah memenuhi standar kelayakan operasional dan akurasi pemeriksaan.

3. Penambahan Alat/Sistem

Pada bulan April dilakukan pemasangan sistem LIS (Laboratory Information System). Implementasi ini merupakan langkah positif dalam meningkatkan efisiensi, akurasi data, serta integrasi pelayanan laboratorium.

4. Penggantian dan Perbaikan Alat

Tidak terdapat kegiatan penggantian maupun perbaikan alat selama periode ini, yang mengindikasikan bahwa kondisi alat laboratorium secara umum masih dalam keadaan baik dan berfungsi optimal.

5. Pemeliharaan Alat

Pemeliharaan alat dilakukan secara berkala melalui kalibrasi setiap 3 bulan oleh vendor. Hal ini menunjukkan adanya upaya preventif untuk menjaga performa alat.

RTL:

1. Pemeliharaan preventif berkelanjutan

Melanjutkan kegiatan pemeliharaan dan kalibrasi alat secara rutin sesuai jadwal untuk menjaga keakuratan dan keandalan alat.

2. Monitoring masa berlaku kalibrasi

Melakukan pemantauan terhadap masa berlaku kalibrasi agar tidak terjadi keterlambatan rekalisasi.

3. Optimalisasi pemanfaatan LIS

Mengembangkan penggunaan LIS secara maksimal, termasuk pelatihan petugas dan integrasi dengan sistem pelayanan lainnya.

4. Evaluasi secara berkala kondisi alat

Melakukan inspeksi rutin untuk mendeteksi dini potensi kerusakan sehingga dapat dilakukan tindakan preventif.

Kesimpulan: Kegiatan MFK di laboratorium telah berjalan dengan baik, ditunjukkan dengan adanya klasifikasi inventaris, kalibrasi alat, serta pemeliharaan rutin. Tidak adanya perbaikan maupun penggantian alat menunjukkan kondisi alat masih optimal. Ke depan, diperlukan monitoring dan evaluasi berkelanjutan untuk mempertahankan mutu dan keselamatan pelayanan laboratorium.

K3

Pada Bulan Mei Tidak Ada Kejadian K3 di Laboratorium Prima Husada Malang

BAB IV MUTU LABORATORIUM

4.1. IMP Unit

Tabel 5.1.1 Hasil Kinerja Pengukuran IMP Unit

No	Indikator	Standar	Hasil
1.	Kejadian ketidaktersediaan Reagen esensial di laboratorium	0	0
2.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%
3.	Pelaporan nilai kritis	100%	100%
4.	Ketersediaan kantong darah sesuai golongan	100%	100%
5.	Survilen harian hemofigen	100%	100%
6	Keterlambatan Hasil Patologi Anatomi sesuai dengan Regulasi	0 %	0 %
7	Kejadian salah input hasil laboratorium	0 %	0 %
8	Waktu tunggu hasil Laboratorium >140	0 %	0 %
9	Kepatuhan kenersihan tangan	>85%	100%
10	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	100%
11	Kepatuhan pelaporan kritis gula darah	100%	100%
12	Angka kepatuhan pengelolaan POCT	100%	100%
13	Waktu kepatuhan hasil Laboratorium Cito <30 menit	100%	100%
14	Kejadian Pengulangan Phlebotomi	0	4

Analisis : Berdasarkan hasil pengukuran indikator mutu (IMP) Unit Laboratorium, secara umum kinerja pelayanan menunjukkan hasil yang sangat baik dan telah memenuhi standar yang ditetapkan. Hal ini terlihat dari hampir seluruh indikator yang mencapai target 100% atau 0% sesuai standar, antara lain tidak adanya kejadian ketidaktersediaan reagen esensial, kepatuhan identifikasi pasien, pelaporan nilai kritis, ketersediaan kantong darah, surveilans harian hemovigilans, serta tidak adanya kesalahan input hasil laboratorium dan keterlambatan hasil.

Selain itu, indikator terkait keselamatan dan kepatuhan petugas seperti kebersihan tangan, penggunaan alat pelindung diri (APD), serta pengelolaan POCT juga menunjukkan hasil optimal dengan capaian 100%.

Namun demikian, terdapat satu indikator yang belum memenuhi standar, yaitu **kejadian pengulangan phlebotomi** dengan target 0 tetapi realisasi sebanyak 4 kejadian. Hal ini mengindikasikan masih adanya kendala dalam proses pengambilan sampel darah, yang dapat

disebabkan oleh faktor teknis (kesulitan vena, hemolisis, volume tidak cukup), faktor pasien, maupun faktor petugas.

RTL:

1. Peningkatan Kompetensi Petugas Phlebotomi
Melakukan pelatihan dan refreshment terkait teknik pengambilan darah yang benar untuk meminimalkan kegagalan pengambilan sampel.
2. Evaluasi Penyebab Pengulangan Phlebotomi
Melakukan analisis lebih lanjut terhadap setiap kejadian pengulangan (misalnya karena hemolisis, clotting, atau kesalahan teknik) sebagai bahan perbaikan berkelanjutan.
3. Penyusunan dan Penegakan SOP
Memastikan standar operasional prosedur (SOP) pengambilan sampel dijalankan secara konsisten oleh seluruh petugas.
4. Monitoring dan Audit Berkala
Melakukan pemantauan rutin terhadap kejadian pengulangan phlebotomi sebagai indikator mutu untuk memastikan adanya perbaikan.
5. Peningkatan Komunikasi dengan Pasien
Memberikan edukasi kepada pasien sebelum tindakan untuk meningkatkan kerja sama selama proses pengambilan sampel.
6. Penyediaan Sarana Pendukung
Memastikan ketersediaan alat phlebotomi yang memadai dan sesuai standar guna mendukung keberhasilan tindakan.

Kesimpulan: Secara umum, kinerja indikator mutu Unit Laboratorium telah memenuhi standar yang ditetapkan dengan capaian optimal pada hampir seluruh indikator. Namun, masih ditemukan ketidaksesuaian pada indikator kejadian pengulangan phlebotomi. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan berkelanjutan melalui peningkatan kompetensi petugas, evaluasi penyebab kejadian, penguatan implementasi SOP, serta monitoring dan audit secara berkala.

Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat menurunkan angka pengulangan phlebotomi hingga mencapai standar yang ditetapkan serta mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan laboratorium secara keseluruhan.

BAB V

SASARAN KESELAMATAN PASIEN (SKP)

Tabel 5.2 Taber SKP Yang dilakukan Di Laboratorium RSPH Malang

No	Insiden	Standar	Jumlah Kejadian	% dari total identifikasi Pasien
1	Mengidentifikasi pasien dengan benar	100%	0	0%
2	Meningkatkan komunikasi yang efektif (HO)	100%	0	0%
3	Koplain Pasien	0	0	0

Analisis: Berdasarkan data **Sasaran Keselamatan Pasien (SKP)** di Laboratorium RSPH Malang, seluruh indikator menunjukkan capaian sesuai dengan standar yang ditetapkan. Tidak ditemukan kejadian insiden pada indikator identifikasi pasien, komunikasi efektif (handover), maupun komplain pasien, dengan persentase kejadian 0%.

Hal ini mengindikasikan bahwa implementasi prosedur keselamatan pasien telah berjalan dengan baik, serta adanya kepatuhan petugas terhadap standar operasional yang berlaku. Selain itu, hasil ini juga mencerminkan efektivitas sistem pengawasan dan budaya keselamatan pasien yang *ইত* telah diterapkan di lingkungan laboratorium.

Meskipun demikian, hasil nihil kejadian tetap perlu dicermati secara kritis untuk memastikan bahwa tidak terjadi underreporting atau ketidaklengkapan insiden.

RTL:

1. Mempertahankan Kepatuhan terhadap Standar SKP
Melanjutkan implementasi prosedur identifikasi pasien dan komunikasi efektif sesuai standar yang berlaku.
2. Peningkatan Budaya Pelaporan Insiden
Mendorong petugas untuk tetap aktif melaporkan setiap kejadian atau potensi insiden (near miss) guna memastikan tidak terjadi underreporting.
3. Monitoring dan Evaluasi Berkala
Melakukan audit dan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan SKP untuk memastikan konsistensi penerapan di lapangan.
4. Peningkatan Kompetensi Petugas
Melaksanakan pelatihan berkala terkait keselamatan pasien, khususnya pada aspek identifikasi pasien dan komunikasi efektif.
5. Penguatan Sistem Dokumentasi
Memastikan seluruh kegiatan dan pelaporan terkait SKP terdokumentasi dengan baik sebagai bagian dari pemenuhan standar mutu dan akreditasi.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemantauan Sasaran Keselamatan Pasien (SKP) di Laboratorium

RSPH Malang, seluruh indikator menunjukkan tidak adanya kejadian insiden dengan capaian 0%, sehingga telah memenuhi standar yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan bahwa penerapan prosedur keselamatan pasien, khususnya dalam identifikasi pasien, komunikasi efektif, dan penanganan komplain, telah berjalan dengan baik. Meskipun demikian, diperlukan upaya mempertahankan dan meningkatkan kualitas melalui monitoring berkala serta penguatan budaya pelaporan insiden untuk memastikan tidak terjadi ketidakterlaporan, sehingga mutu dan keselamatan pelayanan laboratorium tetap terjaga secara optimal.

5.3. Manajemen Risiko

Tabel 5.3.1 Kejadian K3 Di Laboratorium RS Prima Husada Malang

No	Risiko Keselamatan	Upaya Pencegahan	Jumlah Kejadian	Analisis
1	Tertusuk jarum pasien setelah melakukan phelebotomi	Menggunakan teknik "One Hand"	0	Tidak ada kejadian petugas Laboratorium yang tertusuk jarum
2	Kesalahan penulisan hasil	Cross check sebelum hasil di berikan kepada Dokter /Pengirim	0	Tidak ada Kesalahan penginputan Hasil Laboratorium
3	Sampel tumpah di meja kerja	Penempatan sampel yang baik	0	Tidak Terjadi tumpahan Sampel dan cairan di meja kerja laboratorium

Analisis: Berdasarkan data Kejadian K3 di Laboratorium RS Prima Husada Malang, seluruh indikator risiko keselamatan menunjukkan tidak adanya kejadian (0 kasus) selama periode pemantauan. Hal ini mencakup risiko tertusuk jarum, kesalahan penulisan hasil laboratorium, serta kejadian sampel tumpah di meja kerja.

Tidak ditemukannya kejadian tersebut menunjukkan bahwa:

1. Penerapan prosedur keselamatan kerja sudah berjalan dengan baik
2. Kepatuhan petugas terhadap SOP (seperti teknik *one hand*, cross check hasil, dan penanganan sampel) sudah optimal
3. Kesadaran petugas terhadap aspek K3 cukup tinggi

Namun demikian, kondisi nihil kejadian tetap perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan tidak terjadi underreporting atau kejadian yang tidak terdokumentasi.

RTL:

1. Mempertahankan Kepatuhan terhadap SOP K3 Menjaga konsistensi penerapan prosedur keselamatan kerja oleh seluruh petugas laboratorium.
2. Peningkatan Budaya Keselamatan Kerja Mendorong kesadaran petugas untuk selalu bekerja sesuai standar dan melaporkan setiap insiden maupun *near miss*.
3. Monitoring dan Evaluasi Berkala Melakukan audit rutin terhadap penerapan K3 untuk memastikan tidak adanya potensi risiko yang terlewat.

4. Pelatihan dan Refreshment Petugas
Mengadakan pelatihan berkala terkait keselamatan kerja, khususnya penanganan benda tajam dan sampel biologis.
5. Peningkatan Sistem Pelaporan Insiden
Memastikan sistem pelaporan berjalan efektif agar setiap kejadian dapat terdokumentasi dengan baik.

Kesimpulan:

Kejadian K3 di Laboratorium RS Prima Husada Malang selama periode pemantauan menunjukkan hasil nol kejadian, yang menandakan bahwa penerapan keselamatan dan kesehatan kerja telah berjalan dengan baik sesuai standar. Meskipun demikian, diperlukan upaya berkelanjutan dalam monitoring, evaluasi, dan peningkatan budaya keselamatan kerja guna mempertahankan serta meningkatkan mutu dan keamanan lingkungan kerja laboratorium.

BAB VI PKRS

Tabel 7.1.1 Hasil Kinerja program PKRS di Unit Laboratorium RSPH Malang Bulan Mei Tahun 2024

KEGIATAN KIE	Target	Hasil kinerja Bulan		
		Maret	April	Mei
Edukasi individu	100% pasien	100%	100%	100%
		557	760	717

Analisis: Berdasarkan data kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) di Laboratorium:

1. Target edukasi individu pasien: **100%**
2. Capaian kinerja:
 - a. **Maret:** 100% (557 pasien)
 - b. **April:** 100% (760 pasien)
 - c. **Mei:** 100% (717 pasien)

Seluruh bulan menunjukkan **pencapaian target 100%**, artinya semua pasien telah mendapatkan edukasi sesuai standar yang ditetapkan.

Dari sisi jumlah:

1. Terjadi **peningkatan signifikan di bulan April** (760 pasien)
2. Sedikit **penurunan di bulan Mei** (717 pasien), namun masih dalam kategori tinggi dan tetap memenuhi target

Hal ini menunjukkan:

1. Pelaksanaan KIE sudah berjalan **optimal dan konsisten**
2. Petugas memiliki **kepatuhan tinggi terhadap kewajiban edukasi pasien**
3. Fluktuasi jumlah lebih dipengaruhi oleh **jumlah kunjungan pasien**, bukan kinerja petugas

RTL:

1. **Mempertahankan capaian 100%**
Menjaga konsistensi edukasi kepada seluruh pasien tanpa pengecualian.
2. **Standarisasi materi edukasi**
Memastikan informasi yang diberikan seragam, akurat, dan mudah dipahami pasien.

3. Peningkatan kualitas edukasi

Tidak hanya kuantitas (100%), tetapi juga kualitas pemahaman pasien (bisa dengan evaluasi atau feedback).

4. Monitoring dan evaluasi rutin

Melakukan audit berkala terhadap pelaksanaan KIE untuk menjaga mutu layanan.

5. Optimalisasi media edukasi

Menggunakan leaflet, poster, atau media digital untuk mendukung efektivitas penyampaian informasi.

Kesimpulan:

Kegiatan KIE di Laboratorium menunjukkan kinerja sangat baik dengan pencapaian target 100% selama tiga bulan berturut-turut (Maret–Mei). Hal ini mencerminkan tingginya kepatuhan petugas dalam memberikan edukasi kepada pasien. Meskipun terdapat fluktuasi jumlah pasien, kualitas pelayanan tetap terjaga. Upaya selanjutnya difokuskan pada mempertahankan konsistensi serta meningkatkan kualitas edukasi pasien.

BAB VII
JADWAL KEGIATAN

Tabel 7.1.1 Jadwal kegiatan Laboratorium

NO	KEGIATAN	TAHUN 2026 BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	SDM												
	a. Pelatihan Phlebotomi	Sesuai Jadwal Instansi Penyelenggara Pelatihan Phlebotomi											
	b. Evaluasi												
2	Fasilitas												
	a. Pihak ketiga melakukan kalibrasi alat												
	b. IPRS melakukan monitoring												
3	Pengembangan Pelayanan												
	- Bekerjasama dengan PKRS untuk Promosi kesehatan kepada perusahaan dan kelompok masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	- Pelatihan APD	sesuai jadwal yang ditentukan SDM											

Malang, 02 Juni 2026

Penyusun,
Kepala Instalasi/ Bagian



dr Ari Putriani, Sp.PK

Mengetahui
Direktur RS.Prima Husada



dr. Resti Lestantini, M. Kes

A. LAMPIRAN KUANTITAS SDM

Jabatan	Nama	Pendidikan		Pelatihan Dasar RS						Ket.
		Standar	Kondisi saat ini	Mutu dan Keselamatan Pasien	BLS	PP I	Penanggulangan Bencana	Komunikasi Efektif	Pelatihan Phleboto mi	
Penanggung Jawab	dr Ari Putriani Sp.PK	Dokter Sp.PK	Dokter Sp.PK	+	+	+	+	+	-	Penanggung Jawab
Ka Instalasi	Yoga Eka Ramadani Ariwa Amd.AK	D3 Analis Kesehatan	D3 Analis Kesehatan	+	+	+	+	+	+	Kepala Ruang
Pelaksana	Elis Wahyuni Amd AK	D3 Analis Kesehatan	D3 Analis Kesehatan	+	+	+	+	+	-	PJ BMHP + TB
Pelaksana	Puji Utami, Amd.Kes	D3 Analis Kesehatan	D3 Analis Kesehatan	+	+	+	+	+	-	PJ Reagen
Pelaksana	Nikmah Widyawati, S.Tr.Kes	D4 Analis Kesehatan	D4 Analis Kesehatan	+	+	+	+	+	-	PJ QC+HIV
Pelaksana	Arinta Astri M, Amd.Kes	D3 Analis Kesehatan	D3 Analis Kesehatan	+	+	+	+	+	-	PJ ATK
Pelaksana	Lailatul Nur W, Amd.Kes	D3 Analis Kesehatan	D3 Analis Kesehatan	+	+	+	+	+	-	PJ Reagen
Pelaksana	Bagas Dwi Hariono, Amd.Kes	D4 Analis Kesehatan	D4 Analis Kesehatan	+	+	+	+	+	-	PJ Alat
Pelaksana	Nabila Rizki Amalia,S. Tr,Kes	D3 Analis Kesehatan	D3 Analis Kesehatan	+	+	+	+	+	-	PJ PKRS dan Mutu
Pelaksana	Much Farchan A.Amd.Ak	D3 Analis Kesehatan	D3 Analis Kesehatan	+	+	+	+	+	-	PJ ATK

No.	Nama	Jabatan	Skill	Knowledge	Attitude							Catatan
					J	T	V	D	K	A	P	
1	Yoga Eka Ramadani Ariwa ,Amd.AK	Kepala Ruang	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
2	Elis Wahyuni, Amd AK	Analisis pelaksana	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
3	Much Farchan Abdillah,Amd.Ak	Analisis pelaksana	B	B	A	B	A	B	A	B	B	
4	Puji Utami, Amd.Kes	Analisis pelaksana	B	B	B	B	B	A	B	B	B	
5	Nikmah Wisyawati, S.Tr.Kes	Analisis Pelaksana	B	B	A	B	B	B	A	B	B	
6	Nabila Rizki Amalia, S.Tr.Kes	Analisis Pelaksana	B	B	B	A	B	B	A	B	B	
7	Arinta Astri M, Amd.Kes	Analisis Pelaksana	B	B	B	B	B	A	B	B	B	
8	Lailatul Nur W, Amd.Kes	Analisis Pelaksana	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
9	Bagas Dwi Hariono, Amd.Kes	Analisis Pelaksana	B	B	A	B	B	B	B	B	B	
10	Nabila Rizki Amalia S. Tr,Kes	Analisis Pelaksana	B	B	A	B	B	B	B	B	B	

B. LAMPIRAN KUALITAS SDM

C. LAMPIRAN KLASIFIKASI INVENTARIS

No.	Klasifikasi	Nama Alat	Jumlah	Kondisi	Ket.
1	Medis - Listrik	Chemistry Analyzer Indiko	2	Baik	-
3		GEM Premier 3500 Analyzer	1	Baik	-
4		Hipro Reader	1	Baik	-
7		Mikroskop Analyzer	2	Baik	-
8		Mini Vidas	1	Baik	-
10		Centrifuge WINA	1	Baik	-
11		URIT 5160	2	Baik	-

No.	Klasifikasi	Nama Alat	Jumlah	Kondisi	Ket.
1	BMHP	Handsocon	Sesuai Kebutuhan	Baik	-
2		Sputit	Sesuai Kebutuhan	Baik	-
3		Masker	Sesuai Kebutuhan	Baik	-
4		Alkohol Swab	Sesuai Kebutuhan	Baik	-
5		Plesterin Bulat	Sesuai Kebutuhan	Baik	-
6		Pot Urine	Sesuai Kebutuhan	Baik	-
7		Reagen	Lampiran reagen	Baik	-

No.	Klasifikasi	Nama Alat	Jumlah	Kondisi	Ket.
	Non Medis - Listrik	Komputer	2	Layar Buram	Pengajuan Monitor Baru Ke IT
1		Printer	2	Baik	-

2		Telephone portable	1	Baik	-
3		Handphone	1	Baik	-
4		Kulkas	1	Baik	-
5		Show Case	1	Baik	

No.	Klasifikasi	Nama Alat	Jumlah	Kondisi	Ket.
	Non Medis – Non Listrik	Meja admin	1	Baik	-
1		Meja untuk alat	1	Baik	-
2		Kursi dokter	3	Baik	-
3		Kursi plastik	2	Baik	-

D. LAMPIRAN DATA ALAT YANG AKAN DIKALIBRASI

No	Nama Alat (Merk dan Tipe)	No. Seri	Frekuensi			Terakhir Kalibrasi (Hari/ Tgl)	PJ	Pihak Ketiga (Kalibrator)
			Mingguan	Bulanan	Tahunan			
1	Chemistry Analyzer Indiko	863000000268	-	-	√	05-07-2023		PT.Enseval
2	Chemistry Analyzer Indiko	8630000010200	-	-	√	05-07-2023		PT.Enseval
3	GEM Premier 3500 Analyzer	18069915	-	-	√	05-07-2023		PT.Enseval
6	Mikroskop Analyzer	-	-	-	√	15-12-2022		PT.IHS
7	Mini Vidas	IVD1207879	-	-	√	05-07-2023		PT.Enseval
9	THROMBOTIMER 2	010202-00408	-	-	√	08-06-2023		PT. SAS
10	HIPRO A1	HP20111108085	-	-	√	08-06-2023		PT. SAS
11	URIT	55-15008133	-	-	√	08-06-2023		PT.ONE MED
12	URIT	55-15008133	-	-	√	08-06-2023		PT.ONE MED

E. LAMPIRAN PENAMBAHAN ALAT

No.	Nama Alat (Merk dan Tipe)	Kondisi (Secara Rinci)	Rencana Penambahan Alat (Merk dan Tipe)	Jumlah	Ket.		No. Seri
					Proses	Realisasi	
	-	-	-	-	-	-	

F. LAMPIRAN PENGANTIAN ALAT

No.	Nama Alat Lama (Merk dan Tipe)	Alasan Penggantian	Tgl. Pengajuan	Nama Alat Baru (Merk dan Tipe)	Tgl. Penggantian
-	-	-	-	-	-

G. LAMPIRAN PERBAIKAN ALAT RUSAK

No.	Nama Alat (Merk dan Tipe)	No. Seri	Alasan Perbaikan	Tgl. Pengajuan	Tgl. Selesai
-	-	-	-	-	-